

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

J. J. González Fernández, P. Cuesta Fuente, J.T. Camino Acha, L. Honorio-Arroyo.

INTRODUCCIÓN

Es una neuropatía por compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpiano, canal osteofibroso formado por la segunda fila de los huesos carpianos (suelo y paredes) y el ligamento anular del carpo (techo), en la cara palmar de la muñeca. Por este canal discurren los tendones flexores superficiales y profundos de los dedos, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. La compresión de este nervio puede producir distintos síntomas como hormigueos, acorchamientos, calambres, entumecimiento y pérdida de fuerza a nivel de la mano. Con diferencia, es la neuropatía por compresión más frecuente.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa fundamentalmente en el examen físico orientado a confirmar o descartar el síndrome del túnel carpiano y se confirma con pruebas complementarias y de imagen.

1. Examen físico

Los síntomas iniciales sensitivos de sospecha pueden ser adormecimiento, parestesias y dolor a nivel de muñeca y mano sobre el territorio del nervio mediano. Las parestesias más frecuentes ocurren en los dedos pulgar, índice, medio y mitad radial del anular. Conforme progresa la compresión, comienzan los síntomas motores de los músculos aductor corto, flexor corto y oponente del primer dedo. Al paciente se le caen las cosas o tiene dificultades para ciertas maniobras con la mano. En fases avanzadas aparece atrofia de la eminencia tenar y manifiesta debilidad muscular.

Los signos que orientan al diagnóstico son:

- **Signo de Tinel:** la percusión con el martillo de reflejos sobre el ligamento anular-cara palmar de muñeca, produce sensación de parestesias sobre los tres primeros dedos.
- **Signo de Phalen:** la flexión palmar máxima de la mano durante 1-2 minutos, producirá parestesias en los dedos si es positivo, por tensión del ligamento anular.
- **Signo de sacudida (Flick):** es positivo cuando el paciente al ser preguntado "¿Qué hace usted con la mano cuando los síntomas son intensos?" responde agitar la mano de la misma manera que lo hace para bajar la temperatura de un termómetro.

2. Exámenes de laboratorio

Realizaremos análisis de sangre para descartar enfermedades sistémicas como etiología del síndrome de túnel carpiano.

Analítica sanguínea: hemograma, coagulación básica y bioquímica (glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, PCR/VSG, GOT, GPT, uricemia, ANA, FR, TSH y T4).

3. Pruebas de imagen

- **Radiografía de mano y muñeca** en proyección A.P. y lateral. Suele aportar poca información.
- **Radiografía cervical** en proyección A-P. y lateral. Si se sospecha radiculopatía cervical.
- **Electrofisiológicas.** Se coloca electrodos en la mano y la muñeca. Se aplican pequeñas descargas eléctricas y se mide la velocidad con la que se transmiten los impulsos nerviosos.
- **Electromiograma.** Consiste en la introducción de una aguja en el músculo inervado por el

nervio que se está estudiando para medir su actividad eléctrica. Mide la velocidad de conducción nerviosa sensitiva y motora del nervio mediano en la muñeca. El componente sensorial del nervio se ve afectado mucho antes que el motor. En las neuropatías por atrapamiento hay un retraso en la velocidad de conducción motora y sensitiva en el punto de compresión por la desmielinización del nervio mediano. Es la prueba de confirmación y permite valorar el grado de afectación del nervio.

- **Ecografía.** Contribuye al diagnóstico del síndrome del túnel carpiano por causas como ganglión, tenosinovitis, artritis de carpo, etc.
- **TC.** Más útil para el diagnóstico diferencial que para el etiológico.
- **Resonancia magnética.** Útil para el diagnóstico diferencial.

4. Diagnóstico diferencial

- Hipotiroidismo.
- Diabetes
- Fibromialgia.
- Vasculitis.
- Anemia perniciosa.
- IRC

5. Etiología

- Idiopática 50%.
- Traumatismos de repetición (trabajadores con martillos neumáticos).
- Tenosinovitis de flexores.
- Artritis inflamatorias (artritis reumatoide)

TRATAMIENTO

El tratamiento dependerá de la clínica que presente el paciente.

1. Leve-moderado: El tratamiento debe ser conservador con:

- Evitar actividades repetitivas desencadenantes.
- Usar férulas nocturnas en flexión dorsal de la mano.
- Pregabalina a dosis bajas (25 mg).
- AINEs vía oral o intramuscular. Corticoides orales.
- Infiltraciones con corticoesteroides (mejoría transitoria del 80% de pacientes).

2. Graves: El tratamiento debe ser quirúrgico. Se realiza una sección completa del ligamento anular para liberar el nervio.

Indicaciones de tratamiento quirúrgico

- Persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento médico
- Electromiograma con afectación severa del nervio
- Déficit sensitivo o motor establecidos (atrofia de la eminencia tenar)
- Lesión ocupante de espacio
- Síntomas severos o progresivos de más de 12 meses de evolución.

Contraindicaciones tratamiento quirúrgico

- Tumoraciones.
- Neurinomas.

- Quistes sinoviales o gangliones a nivel del canal carpiano.
- Lesión traumática previa a nivel de muñeca que limite la extensión.
- Cirugía previa de Dupuytren.
- Tenosinovitis recurrente u otras inflamaciones palmares.
- Artritis reumatoide.
- Tratamiento con NACO.
- Hemodiálisis.
- Embarazo.
- Anomalías anatómicas conocidas.

BIBLIOGRAFÍA

- Barcenilla A, et al. Carpal tunnel syndrome and its relationship to occupation: a meta-analysis. *Rheumatology (Oxford)*. 2012;51:250-61. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21586523/>
- Atención Primaria en la Red. Fistera.com. Síndrome del túnel carpiano (fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020). Disponible en: [http://www.fisterra.com/guias-clínicas /Atención Primaria en la Red. Fistera.com. Síndrome del túnel carpiano \(fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020\).](http://www.fisterra.com/guias-clínicas/Atención Primaria en la Red. Fistera.com. Síndrome del túnel carpiano (fecha de última revisión el 17 Octubre 2017, acceso 6 de septiembre de 2020).) Disponible en: [http://www.fisterra.com/guias-clínicas /](http://www.fisterra.com/guias-clínicas/)
- Manual de Cirugía Ortopédica y Traumatología 2ª Edición. Capítulo 19.2 Síndromes canaliculares de los miembros. Gomar Sancho F. Silvestre Muñoz A. Editorial Médica Panamericana. 2010.